



NOTULEN

HARI / TANGGAL : KAMIS, 11 SEPTEMBER 2025
PUKUL : 09.30-11.00 WIB
JENIS MEETING : PELAYANAN (RAPAT KOORDINASI DENGAN UNIT IGD)
TEMPAT : HALL SAKURA LT. 5

Berikut hasil notulen :

1	Pokok Bahasan : Mitigasi resiko pasien masuk sampai selesai pulang
	Masalah : 1. Yang menerima pasien adalah security , sejauh mana security bisa mengantar, karena security tidak paham triase 2. Penunggu pasien di IGD masih banyak, lebih dari satu 3. Pasien rawat jalan MRS masuk lewat IGD, SPO nya bagaimana 4. Jika SPO di rawat jalan ada kendala, silahkan di evaluasi segera 5. Resep obat dan bahan habis pakai untuk pasien IGD tidak menunggu billing simrs, dikombinasi dengan kertas dobel. Satu untuk IGD, satu untuk farmasi, harus komitmen dan apakah sudah ada SPO nya, evaluasinya bagaimana 6. Ada asumsi IGD mudah memasukkan pasien, sehingga tidak sesuai dengan yang benar-benar gawat darurat 7. Semua pasien harus terlayani dokter IGD, karena ada pasien HEG (konsulan ke dokter obgyn) yang komplain karena tidak diperiksa dokter IGD 8. Ada pasien fraktur 2 bagian, di bahu dan siku, tetapi yang difotokan penunjang hanya satu bagian saja, apakah perawat tidak mengkonfirmasi atau hanya menjalankan perintah tanpa harus croscek juga 9. SPO serah terima pasien antar shift dan saat transfer bagaimana 10. Kompetensi ketrampilan untuk para dokter silahkan dilakukan, bisa dengan terstruktur dengan spesialis, atau langsung di IGD dengan paramedis
	Keterangan : Pelayanan IGD
	PIC : Dokter IGD, Kains/Karu
	Rencana Tindak Lanjut : 1. Sudah ada di SPO, bahwa Security adalah menerima dan membantu mengarahkan saja ke IGD, yang mendampingi dan melakukan skrining di triase adalah perawat IGD 2. Penunggu pasien di IGD masih banyak, lebih dari satu, maka perlu dikuatkan kembali edukasi dan pengawasan ketat dari depan (security). Ada saran untuk dibuatkan tulisan “ pendamping pasien di IGD hanya 1 orang” 3. Pasien rawat jalan MRS masuk lewat IGD harus masuk kriteria gawat darurat, jika pasien tidak ada kriteria masuk IGD, pasien dari poli dibuatkan alur yang langsung di transfer ke ruangan tanpa melewati IGD. Proses diskusi dengan rawat jalan, verif dan Karu RM. 4. Jika SPO di rawat jalan ada kendala terkait pasien masuk dari poli ke IRNA, selama ini hanya ada yang operasi elektif saja 5. Resep obat dan bahan habis pakai untuk pasien IGD tidak menunggu billing simrs, dikombinasi dengan kertas dobel. Satu untuk IGD, satu untuk farmasi, sudah berjalan dan evaluasi saat SO, selisih saat SO menurun. Tindaklanjut penginputan di billing simrs harus clear dalam satu shift itu juga, tidak boleh dioperkan ke shift selanjutnya 6. Ada asumsi IGD mudah memasukkan pasien, sehingga tidak sesuai dengan yang benar-benar gawat darurat. Perlu adanya refreshing kembali terkait kegawatdaruratan IGD meliputi kondisi yang paling banyak yaitu : sesak, demam, diare, muntah, nyeri 7. Semua pasien harus terlayani dokter IGD, karena ada pasien HEG (konsulan ke dokter obgyn) yang komplain karena tidak diperiksa dokter IGD. Komitmen untuk dokter IGD



	juga harus memeriksa pasien obgyn, karena harus menginfokan kondisi dan hasil konsulan dari dokter obgyn nya agar pasien tenang 8. Ada pasien fraktur 2 bagian, di bahu dan siku, tetapi yang difotokan penunjang hanya satu bagian saja, apakah perawat tidak mengkonfirmasi atau hanya menjalankan perintah tanpa harus croscek juga. Untuk tindaklanjut pasien ini masuk dalam mutu dan keselamatan, karena masuk IKP dan harus dibuatkan RCA. 9. SPO serah terima pasien antar shift dan saat transfer di refresh kembali agar tidak miskomunikasi saat operan 10. Kompetensi ketrampilan untuk para dokter silahkan dilakukan, bisa dengan terstruktur dengan spesialis, atau langsung di IGD dengan paramedis, hal ini bisa dilakukan dengan adanya refreshing ilmu berupa lapsus, materi dari spesialis baik online maupun offline
2	Pokok Bahasan : Saran dan masukan kepala Instalasi IGD
	Masalah : 1. Anamnesa dan pemeriksaan fisik di IGD harus baik, tidak hanya mengandalkan penunjang 2. Untuk paru, pneumonia, skor PSI nya harus sesuai 3. Koordinasi dengan dokter igd, dpjp dan casemix apabila anamnesa sdh seusai, tetapi Lab nya tidak ditemukan abnormalitas, maka harus koordinasi dengan baik untuk mengkaji ulang untuk dicarikan koding nya 4. Riwayat penggunaan obat harus terkaji untuk melihat riwayat penyakit penyerta 5. Apabila ada pending, maka dokter igd juga kena punishment, mgkn HR nya ikut tdk terbayar spt dpjp 6. Penolakan pasien rujukan harus berdasarkan sarana dan prasarana yg memang tdk ada 7. Dokter igd jangan sampai kebingungan, jika ada kesulitan, bisa lapor mod, yanmed atau dokter casemix 8. Jika ada ketidaksesuaian antara anamnesa, pemeriksaan fisik di DRM, dan berkas pending, maka yg ikut menanggung juga dokter igd, tdk hanya dpjp 9. Koordinasi ketat antara tim casemix , dokter igd dan perawat untuk kasus penolakan rujukan
	Keterangan : pelayanan IGD
	PIC : Dokter IGD, Kains/Karu, yanmed, verifikator
	Rencana Tindak Lanjut 1. Anamnesa dan pemeriksaan fisik di IGD harus sesuai dengan pemeriksaan kegawatdaruratan, pemeriksaan penunjang adalah yang paling terakhir, utamakan ke emergency an pasien terlebih dahulu agar bisa terklaime bpjs kesehatan 2. Untuk pasien dengan kondisi sesak karena penyakit paru, seperti Dx pneumonia, skor PSI nya harus sesuai real kondisi pasien, jika tidak sesuai, maka observasi dan pertimbangkan rawat jalan 3. Koordinasi dengan dokter igd, dpjp dan casemix apabila anamnesa sdh seusai, tetapi Lab nya tidak ditemukan abnormalitas, maka harus koordinasi dengan baik untuk mengkaji ulang untuk dicarikan koding nya 4. Riwayat penggunaan obat harus terkaji untuk melihat riwayat penyakit penyerta, karena Riwayat penggunaan obat juga dipertimbangkan dalam menentukan koding bpjs, sehingga obat yang pernah dikonsumsi pasien bisa di dokumentasikan di ERM 5. Dengan adanya sistem proporsi dan untuk pembelajaran dokter IGD, maka yang selama ini penggajian dokter umum untuk fee dokter IGD berdasarkan jumlah pasien MRS, kedepannya jika ada pendingan, maka tim payroll PT harus mendapat data pasien pending dari tim verif (masih diajukan ke PT bagaimana untuk kebijakan selanjutnya) 6. Penolakan pasien rujukan harus berdasarkan sarana dan prasarana yg memang tdk ada, jadi asumsi nya bukan ditolak, melainkan “diarahkan” ke RS yang lebih tinggi 7. Alur dan alternatif jika Dokter IGD bingung atau ada kesulitan, bisa lapor MOD yang shift saat itu, nanti MOD akan lapor ke yanmed atau direktur jika masalahnya belum teratasi, sehingga pasien bisa terhandel dengan baik, dokter bisa fokus meriksa pasien yang lain 8. Jika ada ketidaksesuaian antara anamnesa, pemeriksaan fisik di DRM, dan berkasnya menjadi pending, maka yang ikut menanggung juga dokter IGD dengan tidak dibayarkannya fee MRSnya, sehingga tidak hanya dari segi DPJP saja.



	9. Koordinasi ketat antara tim casemix , dokter igd dan perawat untuk kasus penerimaan rujukan terutama pasien BPJS tunggal untuk pertimbangan plafon.
	Pokok Bahasan : Privasi pasien
	Masalah : 1. Beberapa keluarga pasien dan pengunjung ada yang mengintip dari sela-sela pintu IGD untuk melihat keadaan pasien sehingga pasien yang lain yg memang bukan keluarganya menjadi tidak terjaga privasinya, dan tindakan pemeriksaan dokter IGD dan tindakan keperawatan di triase bisa terlihat dari luar, yang harusnya juga masuk privasi pasien 2. Keluarga pasien banyak yang masuk ke IGD, sudah diingatkan, tetapi keluarga yang lain juga tetap masuk karena tidak ada informasi yang jelas terkait penunggu pasien di IGD
	Keterangan : Pelayanan IGD
	PIC : Unit IGD / IPSRS
	Rencana Tindak Lanjut :
	1. Saran untuk pintu IGD di tutup oleh stiker doff agar tidak terlihat dari luar 2. Saran untuk dibuatkan informasi tertulis yang bisa di tunjukkan oleh dokter maupyn perawat IGD, jika keluarga pasien ada yang tetap masuk lebih dari satu

Pemimpin Rapat
PLT Direktur RS Prima Husada Malang



dr. Resti Lestantini, M.Kes

Malang, 11 September 2025
Notulis



Puput Sekar Nariratih, Amd.Keb



DOKUMENTASI

